Estilo UERJ

Simulado 5 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 80 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 4 horas, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 33 anos, com dois abortamentos de primeiro trimestre e trombose venosa profunda há 3 anos (tratada por 6 meses), chega com cefaleia progressiva há 5 dias e, hoje, crise focal motora no membro superior direito, com recuperação. Exame: sonolenta, papiledema bilateral, paresia leve no membro superior direito. RM com venografia: trombose do seio sagital superior e de veias corticais, com infarto venoso hemorrágico frontoparietal esquerdo de 3 cm. Anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina IgG 80 GPL e anti-beta-2-glicoproteína I IgG 70 U, persistentes após 12 semanas. Plaquetas 180.000/mm³, sódio 138 mEq/L, glicemia 92 mg/dL. Quanto à anticoagulação neste momento e à droga anticrise, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Heparina plena / iniciar anticrise

B) Heparina plena / sem anticrise

C) Adiar por 2 semanas / iniciar anticrise

D) Adiar por 2 semanas / sem anticrise

---

2 Mulher de 67 anos, com diabetes tipo 2 em uso de metformina 2 g/dia e doença renal crônica (creatinina basal de 1,4 mg/dL), tem vômitos incoercíveis há quatro dias por gastroenterite, com ingestão mínima. Exame: sonolenta, PA 92/58 mmHg, FC 114 bpm, mucosas secas. Exames: pH 7,36, pCO2 40 mmHg, bicarbonato 22 mEq/L, sódio 138 mEq/L, cloro 88 mEq/L, potássio 3,2 mEq/L, albumina 4,0 g/dL, lactato 13,6 mmol/L, glicemia 172 mg/dL, beta-hidroxibutirato 0,4 mmol/L, creatinina 2,9 mg/dL. O distúrbio ácido-base é:

A) Ausência de distúrbio relevante

B) Acidose lática com acidose hiperclorêmica

C) Acidose lática com alcalose metabólica

D) Acidose lática isolada compensada

---

3 Mulher de 47 anos, tratada há 3 semanas com amoxicilina-clavulanato por pneumonia comunitária, com melhora da febre e da tosse, retorna porque o hemograma de controle mostrou leucocitose. Refere saciedade precoce e sudorese noturna há 3 meses, desde antes da pneumonia. Exame: afebril, baço palpável a 10 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 10,9 g/dL, leucócitos 156.000/mm³ com mielócitos 14%, metamielócitos 9%, bastões 12%, segmentados 48%, basófilos 7%, eosinófilos 5% e blastos 2%; plaquetas 640.000/mm³. PCR 1,2 mg/dL. O exame que confirma o diagnóstico mais provável é:

A) Fosfatase alcalina leucocitária

B) Pesquisa de JAK2 V617F

C) Hemoculturas e nova radiografia

D) Pesquisa de BCR-ABL1 no sangue

---

4 Mulher de 61 anos, com adenocarcinoma de pulmão metastático, iniciou pembrolizumabe há seis semanas; fez tomografia de estadiamento com contraste iodado há quatro semanas. Refere palpitações e insônia há dez dias. Sem doença tireoidiana prévia. Exame: FC 108 bpm, PA 128/80 mmHg, tremor fino, tireoide de volume normal, indolor, sem nódulos, sem sopro, sem oftalmopatia. Exames: TSH 0,02 µUI/mL, T4 livre 2,4 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 182 ng/dL, TRAb negativo, anti-TPO positivo, cortisol às 8 horas 16 µg/dL, sódio 138 mEq/L. Ultrassonografia: tireoide heterogênea, sem nódulos, com fluxo reduzido. O mecanismo mais provável da tireotoxicose é:

A) Destruição folicular inflamatória

B) Anticorpo estimulador do receptor de TSH

C) Síntese induzida pelo iodo do contraste

D) Autonomia de nódulo tireoidiano

---

5 Homem de 24 anos, que faz sexo com homens, procura o serviço para iniciar PrEP. Relata múltiplas parcerias e uso irregular de preservativo; teve gonorreia há 4 meses. Há 36 horas teve relação anal receptiva sem preservativo com parceria de sorologia desconhecida. Está assintomático. Teste rápido anti-HIV não reagente, creatinina 0,8 mg/dL (clearance estimado acima de 90 mL/min), HBsAg não reagente, VDRL não reagente. A conduta mais adequada é:

A) PEP por 28 dias e transição direta para PrEP

B) Iniciar PrEP hoje, sem PEP

C) PEP e reavaliar a PrEP em 3 meses

D) Repetir o teste em 30 dias, sem medicação

---

6 Homem de 58 anos com carcinoma epidermoide de pulmão em progressão após todas as linhas de tratamento está internado em cuidados paliativos exclusivos, com prognóstico estimado em horas a poucos dias (PPS 10%). Há 2 dias tem dispneia e agitação que persistem apesar de morfina subcutânea titulada, haloperidol, oxigênio e tratamento das causas reversíveis, com sofrimento intenso. Quando lúcido, expressou o desejo de não sofrer no fim, e a família concorda com sedação paliativa. Quanto ao fármaco e à forma de titulação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Morfina em doses crescentes / titulação proporcional

B) Midazolam / titulação proporcional

C) Midazolam / dose para inconsciência imediata

D) Morfina em doses crescentes / dose para inconsciência imediata

---

7 Homem de 61 anos, com tumor neuroendócrino de íleo e múltiplas metástases hepáticas diagnosticados há 3 anos, em uso de octreotida de depósito, refere edema progressivo de membros inferiores e aumento do volume abdominal há 4 meses, sem ortopneia nem dispneia paroxística noturna. Exame: PA 118×72 mmHg, FC 88 bpm, turgência jugular a 45 graus, hepatomegalia, ascite e edema, pulmões limpos. Albumina 3,9 g/dL. Ecocardiograma de 2 anos atrás: câmaras e valvas normais, sem forame oval patente. O achado auscultatório mais provável é:

A) Sistólico ejetivo aórtico com B2 hipofonética

B) Holossistólico paraesternal baixo, maior na inspiração

C) Ruflar diastólico apical com estalido de abertura

D) Holossistólico apical irradiado para a axila

---

8 Mulher de 72 anos é encaminhada para iniciar teriparatida. Teve três fraturas vertebrais por fragilidade (T7, T11 e L1) nos últimos 2 anos, a última durante o uso regular de alendronato por 4 anos, e tem T-escore de -3,4 em coluna lombar e -2,9 em colo femoral. Refere dor surda e contínua na coxa esquerda, pior à noite, há 1 ano, e notou a perna esquerda mais arqueada. Exame físico: arqueamento anterolateral do fêmur esquerdo, com calor local discreto. Exames: cálcio 9,6 mg/dL, fósforo 3,4 mg/dL, 25-hidroxivitamina D 38 ng/mL, PTH 44 pg/mL, creatinina 0,8 mg/dL, fosfatase alcalina 390 U/L (VR até 120), GGT 28 U/L (VR até 40), eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. Radiografia do fêmur esquerdo: espessamento cortical, trabeculado grosseiro e áreas líticas e escleróticas, sem traço de fratura. Antes de definir o tratamento, o exame mais adequado é:

A) Biópsia da lesão femoral

B) Cintilografia óssea de corpo inteiro

C) Ressonância magnética do fêmur

D) Fosfatase alcalina óssea específica

---

9 Homem de 66 anos, engenheiro aposentado, ex-tabagista (25 maços-ano, parou há 20 anos), tem dispneia progressiva e tosse seca há 3 anos. Nega contato com aves, mofo visível em casa, umidificador, edredom ou travesseiro de penas, exposição ocupacional e uso de amiodarona, nitrofurantoína ou metotrexato. Nega Raynaud, artralgia, fraqueza muscular e refluxo. Exame: estertores em velcro bilaterais, baqueteamento digital, SpO2 93% em ar ambiente. TCAR: reticulado com bronquiectasias de tração e faveolamento, mais extenso nos terços superiores e médios e ao longo dos feixes broncovasculares centrais, sem linfonodomegalia; nas bases, lóbulos de atenuação reduzida que escurecem na expiração, lado a lado com áreas de vidro fosco e de parênquima normal. FAN, fator reumatoide, anti-CCP, anti-Scl-70 e painel de miosite negativos. Lavado broncoalveolar: 34% de linfócitos, relação CD4/CD8 de 0,9, culturas negativas. CVF 66% do previsto, DLCO 48%. O diagnóstico mais provável é:

A) Sarcoidose pulmonar fibrótica

B) PINE fibrótica associada a colagenose

C) Fibrose pulmonar idiopática

D) Pneumonite de hipersensibilidade fibrótica

---

10 Homem de 63 anos com cirrose por vírus C (Child-Pugh A5), com resposta virológica sustentada há 4 anos, está em rastreamento semestral. A ultrassonografia mostrou nódulo novo. RM com contraste extracelular: nódulo de 2,4 cm no segmento VIII com hiper-realce arterial não periférico, washout não periférico na fase portal e cápsula realçada na fase tardia; sem invasão vascular e sem outras lesões. Alfafetoproteína 5 ng/mL. Plaquetas 112.000/mm³, bilirrubina 1,0 mg/dL, ECOG 0. A conclusão diagnóstica mais adequada é:

A) Carcinoma hepatocelular, dispensa biópsia

B) Nódulo indeterminado, exige biópsia

C) Nódulo displásico, repetir RM em 3 meses

D) Colangiocarcinoma, exige biópsia

---

11 Mulher de 24 anos procura o clínico antes de extração de terceiros molares. Desde a menarca tem menstruações de 8 dias com coágulos, já usou sulfato ferroso duas vezes e sangrou por 2 dias após amigdalectomia na infância. Tem equimoses fáceis. A mãe "sangra muito no dentista". Não usa medicamentos. Exames: Hb 11,1 g/dL, ferritina 9 ng/mL, plaquetas 260.000/mm³, INR 1,0, TTPa 32 s (controle 30 s), fibrinogênio 290 mg/dL. Escore de sangramento ISTH-BAT de 7. O próximo exame mais adequado é:

A) Fator de von Willebrand e FVIII

B) Dosagem da atividade do fator XI

C) Tempo de sangramento de Ivy

D) Nenhum, o coagulograma é normal

---

12 Homem de 52 anos tem edema progressivo há dois meses. Não é diabético, não usa anti-inflamatório nem outras medicações e nega perda de peso. Exame: PA 132/84 mmHg, edema 3+. Exames: albumina 2,3 g/dL, proteinúria de 24 h de 6,8 g, creatinina 0,9 mg/dL (TFGe de 96 mL/min/1,73 m²), urina com 4 hemácias por campo, sem cilindros; anti-PLA2R 180 RU/mL (positivo acima de 20); FAN, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV e VDRL negativos; C3 e C4 normais; eletroforese de proteínas sem pico monoclonal; rastreamento oncológico para a idade em dia e normal. Em relação à biópsia renal, a conduta mais adequada é:

A) Realizar antes de qualquer tratamento

B) Dispensar neste momento

C) Realizar se anti-THSD7A positivo

D) Realizar após seis meses de IECA

---

13 Mulher de 49 anos, tabagista, chega ao PS 3 horas após cefaleia súbita e explosiva durante esforço evacuatório, com vômitos e síncope breve, sem abalos presenciados pelo marido. Exame: Glasgow 15, rigidez de nuca, sem déficit focal, PA 158/92 mmHg. TC de crânio sem contraste: hemorragia subaracnóidea em cisternas da base e fissura sylviana esquerda, sem hematoma e sem hidrocefalia. Angiotomografia: aneurisma de 7 mm na artéria comunicante posterior esquerda, com embolização programada para as próximas horas. Além do controle pressórico e da analgesia, quanto à nimodipina e à profilaxia de crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Só se houver vasoespasmo / sem anticrise

B) Só se houver vasoespasmo / fenitoína profilática

C) Nimodipina oral desde já / sem anticrise

D) Nimodipina oral desde já / fenitoína profilática

---

14 Homem de 49 anos, pedreiro, natural de Imperatriz (MA), com diabetes tipo 2 há 6 anos em uso de metformina (HbA1c 7,4%), procura atendimento por dormência na borda medial da mão esquerda e no dorso do pé direito há 8 meses, com fraqueza progressiva para segurar ferramentas e tropeços frequentes com o pé direito. Nega queimação nos pés, febre ou perda de peso. Exame: sem manchas, placas ou nódulos em toda a pele; atrofia dos interósseos e garra do 4º e 5º dedos à esquerda; pé caído à direita; hipoestesia térmica e dolorosa no território do ulnar esquerdo e do fibular comum direito; nervo ulnar esquerdo no cotovelo e fibular comum direito na cabeça da fíbula espessados e dolorosos à palpação; aquileus presentes e simétricos; vibração normal nos hálux. Glicemia de jejum 132 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, VHS 18 mm. Baciloscopia de raspado intradérmico de lóbulos e cotovelos: negativa. O diagnóstico mais provável é:

A) Hanseníase neural pura

B) Mononeuropatia múltipla diabética

C) Mononeurite múltipla por vasculite

D) Neuropatias compressivas ulnar e fibular

---

15 Mulher de 26 anos, com diabetes tipo 1 há 12 anos e hipotireoidismo por Hashimoto em levotiroxina, usa glargina e asparte. Nos últimos três meses teve hipoglicemias frequentes e reduziu por conta própria a insulina total de 46 para 30 UI/dia; perdeu 4 kg, com náuseas e cansaço. Nega diarreia, distensão abdominal, esteatorreia ou mudança na dieta; não pratica exercício novo e não usa álcool. Técnica e locais de aplicação adequados, sem lipo-hipertrofia. Exame: PA 96/62 mmHg deitada e 82/54 mmHg em pé, abdome indolor, sem bócio. Exames: HbA1c 6,4% (era 7,8%), sódio 132 mEq/L, potássio 5,3 mEq/L, creatinina 0,8 mg/dL, TSH 2,1 µUI/mL, hemoglobina 12,8 g/dL, ferritina 64 ng/mL. A causa mais provável da queda da necessidade de insulina é:

A) Gastroparesia diabética

B) Doença celíaca

C) Hipotireoidismo mal controlado

D) Insuficiência adrenal primária

---

16 Homem de 69 anos, preto, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, usa há 14 meses sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, furosemida e a associação de nitrato com vasodilatador arterial direto. Há 5 semanas apresenta febre baixa, artralgia de mãos e punhos e dor torácica pleurítica. Nega fotossensibilidade, úlceras orais, alopecia, edema novo e alterações urinárias. Exame físico: T 37,8 °C, atrito pleural em base esquerda, artrite em 2 metacarpofalângicas, sem lesões cutâneas. Exames: Hb 12,6 g/dL, leucócitos 4.200/mm³, plaquetas 210.000/mm³, creatinina 1,1 mg/dL, EAS normal, C3 e C4 normais, FAN 1:640 com padrão nuclear homogêneo. Radiografia: pequeno derrame pleural à esquerda. O autoanticorpo mais provavelmente reagente neste paciente é:

A) Anti-histona

B) Anti-Sm

C) Anti-Ro/SSA

D) Anti-DNA nativo

---

17 Ensaio clínico de não inferioridade comparou um anticoagulante oral novo à varfarina na prevenção de AVC na fibrilação atrial. A margem de não inferioridade pré-especificada foi de 1,38 para a razão de riscos (hazard ratio). O resultado foi hazard ratio de 0,88, com intervalo de confiança de 95% de 0,75 a 1,03 na análise por protocolo e de 0,77 a 1,06 por intenção de tratar. A conclusão correta é que o novo anticoagulante é:

A) Superior à varfarina

B) Equivalente à varfarina

C) Não inferior, sem superioridade demonstrada

D) Inconclusivo, pois o intervalo cruza 1

---

18 Rapaz de 17 anos procura atendimento por dor e edema que migram entre joelhos, tornozelos e cotovelos há 10 dias, febre de até 38,5 °C e cansaço. Teve faringite não tratada 3 semanas antes. Exame: Tax 37,4 °C, FC 118 bpm, sopro holossistólico apical irradiado para a axila e sopro mesodiastólico curto, de baixa frequência, no ápice, sem estalido de abertura e sem reforço pré-sistólico. ASLO 820 UI/mL, VHS 92 mm/h, intervalo PR de 220 ms. Ecocardiograma: espessamento discreto dos folhetos mitrais com insuficiência moderada, sem fusão comissural, área valvar normal. O sopro diastólico corresponde a:

A) Sopro de Graham Steell

B) Sopro de Austin Flint

C) Estenose mitral reumática

D) Sopro de Carey Coombs

---

19 Mulher de 27 anos tem anemia ferropriva refratária a ferro oral há 2 anos, distensão abdominal e evacuações amolecidas. Teve três episódios de sinusite bacteriana e duas giardíases tratadas nos últimos 3 anos. Mãe com tireoidite de Hashimoto. Exame: IMC 19 kg/m², palidez, sem outras alterações. Exames: hemoglobina 9,8 g/dL, ferritina 6 ng/mL, albumina 3,8 g/dL; anti-transglutaminase IgA de 0,4 U/mL (negativo abaixo de 7), colhido em dieta habitual com glúten. Para interpretar corretamente esse resultado, o exame necessário é:

A) Anti-endomísio IgA

B) HLA-DQ2 e DQ8

C) IgA sérica total

D) Biópsia duodenal

---

20 Homem de 30 anos recebe hoje o diagnóstico de HIV na UBS. Está assintomático: nega tosse, febre, sudorese noturna e perda de peso. Exame físico normal. Radiografia de tórax normal. CD4 80 células/mm³, carga viral 180.000 cópias/mL, IgG para toxoplasmose reagente, VDRL não reagente, antígeno criptocócico sérico não reagente, HBsAg não reagente, anti-HBs negativo. Nunca tratou tuberculose nem teve contato conhecido. Inicia hoje tenofovir, lamivudina e dolutegravir e sulfametoxazol-trimetoprima. Além do sulfametoxazol-trimetoprima, a profilaxia indicada agora é:

A) Nenhuma profilaxia adicional

B) Fluconazol diário

C) Azitromicina semanal

D) Tratamento preventivo da tuberculose

---

21 Mulher de 44 anos, com 3 gestações prévias, recebeu 2 concentrados de hemácias compatíveis há 8 dias, durante histerectomia por miomatose com sangramento. Teve alta no 3º dia com Hb de 10,1 g/dL. Hoje retorna com icterícia, urina escura e cansaço. Desde a alta usa dipirona e cefalexina por infecção da ferida operatória. Exames: Hb 7,4 g/dL, reticulócitos 6%, LDH 820 U/L, bilirrubina indireta 3,6 mg/dL, haptoglobina indetectável, Coombs direto positivo (IgG), esfregaço com esferócitos e sem esquizócitos. A pesquisa de anticorpos irregulares é positiva para anti-Jka, ausente na amostra pré-transfusional. O diagnóstico mais provável é:

A) Reação hemolítica aguda por ABO

B) Anemia hemolítica autoimune quente

C) Hemólise imune induzida por cefalexina

D) Reação hemolítica transfusional tardia

---

22 Homem de 70 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 25%), está no terceiro dia de internação por descompensação com congestão e perfusão preservada. Recebe furosemida 80 mg IV de 12 em 12 horas e perdeu 3 kg, mas ainda tem turgência jugular, estertores em bases e edema 2+. Exame: PA 112/70 mmHg, FC 84 bpm, extremidades quentes, enchimento capilar normal. Exames: creatinina de 1,3 mg/dL na admissão para 1,7 mg/dL hoje, potássio 4,2 mEq/L, lactato 1,1 mmol/L; sódio urinário colhido duas horas após a dose de furosemida de 96 mEq/L, com diurese de 2.400 mL nas últimas 24 horas. A conduta mais adequada é:

A) Suspender a furosemida e hidratar

B) Reduzir a furosemida pela metade

C) Manter a furosemida até a descongestão

D) Iniciar dobutamina

---

23 Na doença de Alzheimer em fase de comprometimento cognitivo leve, com patologia amiloide confirmada e demais critérios preenchidos, a condição que, isoladamente, contraindica o uso de anticorpo antiamiloide (lecanemabe ou donanemabe) pelas recomendações de uso apropriado é:

A) Uso de anticoagulante oral

B) Idade acima de 75 anos

C) Uso de donepezila

D) Heterozigose para APOE ε4

---

24 Homem de 24 anos procura atendimento por dor e edema no joelho esquerdo e no tornozelo direito há 10 dias, dor no calcanhar direito ao caminhar e olhos vermelhos sem perda visual. Há 4 semanas teve ardor ao urinar e secreção uretral clara, não tratados, que persistem leves. Tem parceira nova há 2 meses, sem preservativo. Exame físico: T 37,6 °C, artrite de joelho esquerdo e tornozelo direito, entesite do tendão de Aquiles direito, conjuntivite bilateral, sem lesões de pele ou mucosas. Exames: VHS 48 mm/h, PCR 5,2 mg/dL, HLA-B27 reagente, teste de amplificação de ácidos nucleicos na urina positivo para Chlamydia trachomatis e negativo para gonococo, anti-HIV e VDRL não reagentes. Líquido sinovial inflamatório, sem cristais, com Gram e cultura negativos. Quanto ao antimicrobiano e ao tratamento da artrite, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Doxiciclina por 3 meses / AINE

B) Doxiciclina por 3 meses / sulfassalazina

C) Doxiciclina por 7 dias / AINE

D) Doxiciclina por 7 dias / sulfassalazina

---

25 Mulher de 36 anos, tabagista (8 maços-ano), teve há 3 semanas o segundo pneumotórax espontâneo, à direita, tratado com drenagem torácica; o primeiro foi à esquerda, há 1 ano. Refere dispneia aos grandes esforços há 2 anos, atribuída a asma, sem melhora com broncodilatador. Nega lesões de pele, convulsões, doença renal e história familiar de pneumotórax. Exame: SpO2 96% em ar ambiente, sem pápulas faciais nem angiofibromas, murmúrio discretamente reduzido à direita. TCAR após a reexpansão: dezenas de cistos de paredes finas, redondos e de tamanho uniforme (2 a 10 mm), distribuídos difusamente do ápice às bases, incluindo os seios costofrênicos, sem nódulos e sem vidro fosco. TC de abdome e pelve sem angiomiolipoma renal, sem linfonodomegalia e sem ascite. Espirometria: VEF1/CVF 0,66; DLCO 61% do previsto. Para confirmar o diagnóstico, o próximo exame mais adequado é:

A) Dosagem sérica de VEGF-D

B) Criobiópsia transbrônquica

C) Dosagem de alfa-1 antitripsina

D) Pesquisa de mutação do gene FLCN

---

26 Homem de 52 anos, com hipertensão em uso de losartana, anlodipino e clortalidona, diabetes tipo 2 diagnosticado há 2 anos e apneia obstrutiva do sono (índice de apneia e hipopneia de 38 eventos por hora) em uso de CPAP, foi operado de síndrome do túnel do carpo à direita há 1 ano e agora tem parestesias também na mão esquerda. Refere sudorese excessiva e cefaleia frequente. Conta que precisou alargar a aliança e que o número do sapato passou de 41 para 43 nos últimos anos. Exame: PA 148 × 92 mmHg, IMC 29 kg/m², pele espessa e oleosa, espaçamento entre os incisivos inferiores, mãos largas, campos visuais normais à confrontação. Glicemia de jejum 176 mg/dL, HbA1c 8,1%, potássio 4,2 mEq/L. Para investigar a principal hipótese diagnóstica, o primeiro exame a ser solicitado é:

A) Ressonância magnética de sela túrcica

B) IGF-1 sérico

C) GH sérico basal

D) GH após sobrecarga oral de glicose

---

27 Homem de 67 anos, com infarto anterior há 6 anos, chega com palpitações há 2 horas. Conta que, aos 30 anos, tinha crises de coração acelerado que cediam ao prender a respiração. Está lúcido, sem dor torácica, PA 128×80 mmHg, perfusão periférica boa, FC 168 bpm regular. ECG: taquicardia regular de QRS largo (160 ms), morfologia de bloqueio de ramo direito com eixo desviado para a esquerda, em DII, ondas P a cerca de 80 bpm que marcham sem relação com os QRS, e alguns complexos de largura intermediária entre o QRS sinusal e o da taquicardia. Manobra vagal sem efeito. O diagnóstico mais provável é:

A) Flutter atrial 2:1 com aberrância

B) Taquicardia antidrômica por via acessória

C) Taquicardia ventricular monomórfica

D) TSV com aberrância de condução

---

28 Homem de 66 anos, não diabético, sem uso de medicamentos ou álcool, tem episódios de confusão e sudorese ao amanhecer há 3 semanas. Em um episódio, a glicemia capilar foi de 38 mg/dL, com melhora após glicose. Perdeu 8 kg em 6 meses. TC: massa de 18 cm no hemitórax direito, de origem pleural, sem lesões hepáticas, adrenais normais. Creatinina 0,9 mg/dL, cortisol matinal 19 µg/dL. Em nova hipoglicemia, de 41 mg/dL, colheu-se sangue antes da glicose. O perfil esperado nessa amostra é:

A) Insulina alta, peptídeo C alto, beta-hidroxibutirato baixo

B) Insulina alta, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato baixo

C) Insulina baixa, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato baixo

D) Insulina baixa, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato alto

---

29 Homem de 37 anos, com HIV diagnosticado há 10 dias, CD4 32 células/mm³ e carga viral 350.000 cópias/mL, iniciou tenofovir, lamivudina e dolutegravir, além de sulfametoxazol-trimetoprima. Está assintomático: sem alteração visual, moscas volantes, odinofagia, diarreia ou dor abdominal. Exame físico normal. Antes de iniciar a TARV, foi solicitado PCR quantitativo para citomegalovírus no plasma, que resultou em 2.400 cópias/mL; IgG para CMV reagente. Fundoscopia sob midríase realizada pelo oftalmologista: normal. A conduta mais adequada é:

A) Ganciclovir intravenoso por 21 dias

B) Manter a TARV, sem anti-CMV

C) Valganciclovir oral preemptivo

D) Suspender a TARV e repetir o PCR

---

30 Mulher de 56 anos está no 5º dia de internação por pielonefrite com sepse, sem vasopressor desde ontem, com lactato normal e alimentando-se. Tem hipotireoidismo; não tem doença coronariana nem insuficiência cardíaca e não há sangramento ativo. Refere cansaço ao caminhar no corredor. Exame: FC 92 bpm, PA 118 × 70 mmHg, SpO2 97% em ar ambiente. Exames: Hb 7,3 g/dL (9,8 na admissão, queda atribuída à hemodiluição e às coletas), VCM 88 fL, plaquetas 190.000/mm³, ferritina 680 ng/mL, saturação de transferrina 14%. A conduta mais adequada em relação à anemia neste momento é:

A) Transfundir 1 concentrado de hemácias

B) Transfundir 2 concentrados de hemácias

C) Não transfundir e reavaliar

D) Alfaepoetina subcutânea

---

31 Mulher de 28 anos apresenta há 6 dias dor ao mover o olho direito e perda visual central nesse olho. Nunca teve sintomas neurológicos. Exame: acuidade 20/100 no olho direito, defeito pupilar aferente relativo à direita, fundo de olho normal, restante do exame normal. RM de encéfalo: nervo óptico direito com hipersinal e realce; três lesões periventriculares ovoides e uma justacortical, sendo uma periventricular com realce pelo gadolínio e as demais sem realce; RM de medula normal. Anti-aquaporina-4 e anti-MOG negativos. Líquor sem bandas oligoclonais. Pelos critérios de McDonald, a conclusão mais adequada é:

A) Esclerose múltipla definida

B) EM provável, repetir RM em 6 meses

C) Síndrome radiologicamente isolada

D) Síndrome clinicamente isolada

---

32 Mulher de 32 anos teve trombose venosa profunda femoral esquerda não provocada há 3 anos, com anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e anti-beta2-glicoproteína I reagentes em títulos altos, confirmados após 12 semanas. Usa varfarina desde então, com INR na faixa terapêutica e sem novos eventos. Não tem LES. Há 5 anos teve um aborto espontâneo com 7 semanas. Hoje, com 6 semanas de amenorreia, teste de gravidez positivo. A varfarina será substituída por enoxaparina. Quanto à dose da enoxaparina e ao AAS em dose baixa durante a gestação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Dose profilática / sem AAS

B) Dose profilática / com AAS

C) Dose terapêutica / sem AAS

D) Dose terapêutica / com AAS

---

33 Mulher de 66 anos, tratada para tuberculose pleural à esquerda há 20 anos, tem dispneia progressiva há 2 meses, sudorese noturna e perda de 7 kg. Nega trauma ou cirurgia torácica. Exame: macicez em dois terços do hemitórax direito, sem linfonodos periféricos palpáveis, baço palpável a 2 cm do rebordo. Toracocentese à direita: líquido leitoso e inodoro, triglicerídeos 420 mg/dL, colesterol 64 mg/dL, proteína 4,1 g/dL, LDH 310 U/L, 3.800 células/mm³ (92% linfócitos), ADA 18 U/L, citologia oncológica negativa. TC: derrame pleural direito livre, pleura fina, sem espessamento; linfonodomegalias mediastinais e retroperitoneais de até 3 cm; espessamento pleural calcificado residual à esquerda. O tipo de derrame e o exame seguinte mais adequado são, respectivamente:

A) Pseudoquilotórax / biópsia pleural por toracoscopia

B) Quilotórax / biópsia pleural por toracoscopia

C) Pseudoquilotórax / citometria de fluxo do líquido

D) Quilotórax / citometria de fluxo do líquido

---

34 Homem de 46 anos tem HBsAg reagente conhecido há 15 anos, sempre com HBeAg não reagente e anti-HBe reagente, e nunca foi tratado. Assintomático, não usa álcool; exame normal. Nos últimos 12 meses: ALT de 92, 78 e 110 U/L (referência até 40 U/L); HBV-DNA 64.000 UI/mL; anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV não reagentes; elastografia hepática 8,9 kPa; ultrassonografia sem nódulos; IMC 24 kg/m², sem esteatose. A fase da infecção e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Infecção crônica HBeAg negativo / seguimento sem antiviral

B) Hepatite crônica HBeAg negativo / seguimento sem antiviral

C) Infecção crônica HBeAg negativo / tenofovir

D) Hepatite crônica HBeAg negativo / tenofovir

---

35 Mulher de 31 anos, sem comorbidades, com teste de gravidez negativo, foi diagnosticada com pielonefrite há 40 horas (febre de 39,5 °C, dor lombar direita e punho-percussão dolorosa) e está em uso de ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas por via oral, com urocultura colhida antes da primeira dose. Retorna hoje: teve pico febril de 38,3 °C pela manhã, menor que os anteriores, a dor lombar melhorou, aceita bem a dieta e não tem vômitos. Exame: PA 118/74 mmHg, FC 92 bpm, bom estado geral. Exames: creatinina 0,7 mg/dL, leucócitos 12.400/mm³ (eram 17.900). A urocultura mostrou Escherichia coli sensível ao ciprofloxacino, que será mantido. Quanto a exames complementares, o mais adequado neste momento é:

A) Hemoculturas e nova urocultura

B) Tomografia de abdome com contraste

C) Ultrassonografia de vias urinárias

D) Nenhum exame complementar agora

---

36 Homem de 52 anos, com hiperaldosteronismo primário por adenoma esquerdo confirmado por cateterismo adrenal, usava espironolactona 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia e cloreto de potássio 1,8 g/dia antes da adrenalectomia laparoscópica esquerda, há três semanas. Na alta, as três medicações foram mantidas até a consulta. Hoje: PA 122/76 mmHg, FC 74 bpm. Exames: sódio 134 mEq/L, potássio 6,1 mEq/L, creatinina 1,5 mg/dL (era 1,0 antes da cirurgia), aldosterona plasmática abaixo de 3 ng/dL, renina baixa. ECG com ondas T apiculadas, sem alargamento de QRS. Além de suspender o cloreto de potássio e tratar a hipercalemia, quanto à espironolactona e à ingestão de sal, a conduta é, respectivamente:

A) Manter / restrição de sal

B) Manter / dieta liberal em sal

C) Suspender / restrição de sal

D) Suspender / dieta liberal em sal

---

37 Homem de 52 anos, com prolapso mitral conhecido, está internado há 6 dias com endocardite por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina em valva mitral nativa, em uso de oxacilina, com hemoculturas negativas desde o 3º dia. No 5º dia teve hemiparesia braquial direita que regrediu parcialmente; tomografia e ressonância mostram infarto cortical frontal de 2 cm, sem transformação hemorrágica. Glasgow 15. Ecocardiograma transesofágico de hoje: vegetação móvel de 16 mm no folheto anterior mitral, insuficiência mitral moderada, sem abscesso, FE 60%. Sem sinais de insuficiência cardíaca. A conduta mais adequada em relação à cirurgia é:

A) Cirurgia urgente, nos próximos dias

B) Cirurgia após 4 semanas do AVC

C) Antibiótico por 6 semanas, sem cirurgia

D) Cirurgia só se houver nova embolia

---

38 Homem de 63 anos, diabético, que tratou furunculose em coxa há 1 mês, procura atendimento por dor lombar progressiva há 3 semanas, pior à noite, e febre há 5 dias. Nega trauma. Exame: T 38,4 °C, dor à percussão de L3 e L4, força, sensibilidade e reflexos preservados nos membros inferiores, esfíncteres preservados. Hemoculturas: Staphylococcus aureus sensível à oxacilina em 2 de 2 amostras. Ecocardiograma transesofágico sem vegetações. RM de coluna lombar: espondilodiscite L3-L4 com edema dos corpos vertebrais adjacentes e pequeno flegmão paravertebral, sem abscesso epidural ou compressão neural. Iniciada oxacilina. Duas semanas depois, está afebril, com dor em melhora, hemoculturas de controle negativas e PCR caindo de 18 para 4 mg/dL. Quanto à biópsia vertebral e à RM de controle ao fim do tratamento, as indicações são, respectivamente:

A) Indicada / indicada

B) Indicada / dispensável

C) Dispensável / indicada

D) Dispensável / dispensável

---

39 Mulher de 27 anos, com anemia falciforme (HbSS), é acompanhada no hemocentro. Há 1 ano, após três internações por crise vaso-oclusiva e uma síndrome torácica aguda, passou a tomar "uma cápsula diária que reduz as crises", com redução importante das dores. Usa também ácido fólico. É vegetariana estrita há 5 anos, sem suplementos. Assintomática. Exames: Hb 9,4 g/dL (basal anterior de 7,8), VCM 118 fL (era 88), reticulócitos 4% (eram 12%), leucócitos 5.800/mm³, neutrófilos 3.100/mm³, plaquetas 260.000/mm³, LDH 380 U/L (era 790) e hemoglobina fetal de 22% (era 6%). A explicação mais provável para a elevação do VCM é:

A) Deficiência de vitamina B12 pela dieta

B) Efeito esperado da hidroxiureia

C) Síndrome mielodisplásica secundária

D) Deficiência de folato por hemólise

---

40 Homem de 29 anos, fisiculturista, usa estanozolol e oxandrolona há 4 anos. Ultrassonografia feita por dor abdominal vaga mostrou nódulo hepático. RM com contraste hepatoespecífico: lesão única de 3,6 cm no segmento VI, com realce arterial, hipointensa na fase hepatobiliar, com áreas de gordura intralesional e sem cicatriz central; fígado sem sinais de hepatopatia crônica e sem sangramento. Alfafetoproteína 2 ng/mL; sorologias para hepatites B e C negativas. Exame físico normal. O diagnóstico mais provável e a conduta, além de suspender os anabolizantes, são, respectivamente:

A) Hiperplasia nodular focal / RM em 6 meses

B) Hiperplasia nodular focal / ressecção

C) Adenoma hepatocelular / RM em 6 meses

D) Adenoma hepatocelular / ressecção

---

41 Mulher de 63 anos tem artrite reumatoide soropositiva há 19 anos, erosiva, com deformidades em mãos, em uso de leflunomida 20 mg/dia e prednisona 5 mg/dia. Há 4 meses refere formigamento nas mãos, pior à noite, dor occipital e sensação de choque que desce pela coluna ao fletir o pescoço; nas últimas semanas deixa cair objetos e tropeça com frequência. Aguarda artroplastia de quadril sob anestesia geral. Exame físico: sinovite discreta em punhos, sinal de Tinel positivo nos dois punhos, força grau 4 em mãos, reflexos bicipitais e patelares vivos, sinal de Hoffmann positivo bilateralmente, reflexo cutaneoplantar em extensão à direita, sensibilidade vibratória reduzida nos pés. Exames: VHS 42 mm/h, PCR 1,8 mg/dL, glicemia, vitamina B12 e TSH normais. O diagnóstico que explica o quadro neurológico é:

A) Mononeurite múltipla por vasculite

B) Mielopatia por subluxação atlantoaxial

C) Polineuropatia pela leflunomida

D) Síndrome do túnel do carpo bilateral

---

42 Homem de 52 anos, tabagista ativo (35 maços-ano), tem tosse e chiado há 2 anos, com piora no inverno e ao sentir cheiro de tinta, e despertares noturnos por falta de ar. Refere rinite desde a juventude. Exame: sibilos expiratórios esparsos, SpO2 96% em ar ambiente. Eosinófilos 410/mm³. Espirometria: antes do broncodilatador, VEF1/CVF 0,65, VEF1 2,20 L (64% do previsto) e CVF 3,40 L; após salbutamol, VEF1/CVF 0,75, VEF1 2,80 L (81% do previsto) e CVF 3,74 L. O diagnóstico mais provável é:

A) DPOC com resposta ao broncodilatador

B) Asma em tabagista ativo

C) Sobreposição de asma e DPOC

D) Relação preservada com VEF1 reduzido

---

43 Mulher de 61 anos, com artrite reumatoide soropositiva há 22 anos, de controle irregular (PCR persistentemente entre 30 e 60 mg/L), em uso de prednisona 5 mg/dia. Proteinúria de 1,2 g/24 h detectada há dois anos, sem seguimento. Há dois meses começou naproxeno por piora das dores e, há quatro semanas, tem edema progressivo. Exame: PA 118/72 mmHg, edema 3+, fígado a 4 cm do rebordo costal, sem macroglossia, sem púrpura periorbitária. Exames: albumina 2,1 g/dL, proteinúria de 24 h de 7,2 g, creatinina 1,4 mg/dL, urina sem hematúria e sem leucocitúria; eletroforese e imunofixação séricas sem componente monoclonal; relação kappa/lambda das cadeias leves livres de 1,3. Ultrassonografia: rins de 13,5 cm. O diagnóstico mais provável é:

A) Nefropatia membranosa por AINE

B) Amiloidose AL

C) Lesão mínima por AINE

D) Amiloidose AA

---

44 Homem de 73 anos, diabético e hipertenso, nota visão dupla súbita ao acordar. Exame: no olhar para a esquerda, nenhum dos dois olhos ultrapassa a linha média; no olhar para a direita, o olho direito abduz com nistagmo e o olho esquerdo não ultrapassa a linha média. Convergência preservada, com adução de ambos os olhos. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose, força e sensibilidade normais nos membros. Glicemia 212 mg/dL, HbA1c 9,4%. A topografia mais provável da lesão é:

A) Nervo abducente esquerdo

B) Ponte direita: núcleo do VI e FLM

C) FLM esquerdo isolado

D) Ponte esquerda: núcleo do VI e FLM

---

45 Mulher de 74 anos é trazida pela filha, em julho, por sonolência progressiva há uma semana, após pneumonia tratada em casa. Há 18 anos fez tratamento com iodo radioativo para tireoide acelerada e perdeu o seguimento; não toma remédios regularmente. Exame: Glasgow 9, temperatura axilar 34,2 °C, FC 48 bpm, PA 92/58 mmHg, FR 10 irpm, face infiltrada, macroglossia, pele seca e fria, edema não depressível em pernas, relaxamento lento do reflexo aquileu. Exames: sódio 121 mEq/L, glicemia 62 mg/dL, pH 7,28, pCO2 62 mmHg, CPK 1.480 U/L, creatinina 1,4 mg/dL. Os exames de tireoide foram colhidos e o resultado sai amanhã. A conduta medicamentosa mais adequada agora é:

A) Aguardar TSH e T4 livre para tratar

B) Levotiroxina venosa isolada em ataque

C) Hidrocortisona e levotiroxina venosas

D) Levotiroxina oral plena, sem corticoide

---

46 Mulher de 66 anos, diabética, internada há 5 dias por abscesso hepático piogênico de 6 cm, drenado por via percutânea no 1º dia, com choque séptico já resolvido. Iniciou ceftriaxona e metronidazol na admissão, trocados no 2º dia por piperacilina-tazobactam, quando hemoculturas e cultura do abscesso mostraram Escherichia coli produtora de betalactamase de espectro estendido (ESBL), sensível a piperacilina-tazobactam (CIM 4 mg/L), ertapenem, meropenem e amicacina, e resistente a ceftriaxona, cefepima e ciprofloxacino. Sorologia para ameba negativa. Está afebril há 48 horas, sem vasopressor, com hemocultura de controle negativa e dreno com débito em queda. Creatinina 1,1 mg/dL, albumina 3,4 g/dL. Em relação ao antimicrobiano, a conduta mais adequada é:

A) Manter piperacilina-tazobactam até o fim

B) Trocar para ertapenem

C) Trocar para ciprofloxacino oral

D) Associar amicacina ao esquema atual

---

47 Mulher de 62 anos, com transtorno de ansiedade generalizada em uso de sertralina, hipertensa e ex-tabagista, refere há 2 meses dor em aperto retroesternal ao subir a ladeira de casa ou carregar compras, que cede em 3 a 5 minutos de repouso. Diz que a dor piora quando está nervosa e foi liberada duas vezes da emergência com diagnóstico de crise de ansiedade, com ECG e troponina normais nas duas vezes. Exame normal, PA 134×82 mmHg. ECG de repouso normal e ecocardiograma normal. O próximo exame mais adequado é:

A) Nenhum; ajustar o tratamento da ansiedade

B) Teste não invasivo para doença coronária

C) Cineangiocoronariografia

D) Holter de 24 horas

---

48 Homem de 56 anos, sem antecedente familiar de câncer colorretal, faz a primeira colonoscopia de rastreamento, com preparo adequado e exame completo até o ceco. Foram ressecados por completo dois pólipos de 5 e 7 mm, cujo histopatológico mostrou adenomas tubulares com displasia de baixo grau. O intervalo até a próxima colonoscopia é:

A) 6 meses

B) 1 ano

C) 3 anos

D) 7 a 10 anos

---

49 Homem de 62 anos, assintomático, é encaminhado por pico monoclonal achado em exame de rotina. Sem dor óssea e sem infecções de repetição. Exames: Hb 13,6 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, cálcio 9,6 mg/dL, pico monoclonal IgA lambda de 2,1 g/dL, cadeia leve livre lambda de 1.480 mg/L e kappa de 9 mg/L (razão envolvida/não envolvida 164), medula óssea com 22% de plasmócitos clonais. Ressonância de corpo inteiro sem lesões focais e tomografia de baixa dose sem lesões líticas. A conduta mais adequada é:

A) Observação com reavaliação trimestral

B) Tratamento do mieloma múltiplo

C) Bifosfonato isolado

D) Daratumumabe para mieloma latente

---

50 Mulher de 33 anos tem espondilite anquilosante com sacroiliíte bilateral na ressonância e HLA-B27 reagente, com dor lombar inflamatória, BASDAI 6,4 e PCR 3,1 mg/dL, apesar do uso sequencial, em dose plena, de naproxeno e de celecoxibe por 4 semanas cada. Não tem artrite periférica, psoríase, uveíte ou sintomas intestinais, e a calprotectina fecal é normal. Acompanha na neurologia por dois surtos prévios (neurite óptica à esquerda e síndrome sensitiva medular), com lesões periventriculares e justacorticais na ressonância, e está em uso de teriflunomida, estável. O tratamento mais adequado para a espondilite é:

A) Secuquinumabe

B) Adalimumabe

C) Sulfassalazina

D) Prednisona 10 mg/dia contínua

---

51 Homem de 27 anos, com esquizofrenia estável em uso de haloperidol na mesma dose há 3 anos, corria uma prova de 10 km às 11 horas, com temperatura ambiente de 34 °C, quando caiu no 9º km. Chega à tenda médica 10 minutos depois, agitado e desorientado. Temperatura retal 41,4 °C, FC 138 bpm, PA 104 × 60 mmHg, FR 30 irpm, pele quente e úmida. Pupilas isocóricas, tônus muscular normal, sem rigidez, sem clônus e reflexos simétricos, sem rigidez de nuca. Glicemia 96 mg/dL, sódio 136 mEq/L, CK 2.400 U/L. O diagnóstico mais provável é:

A) Golpe de calor por esforço

B) Síndrome neuroléptica maligna

C) Meningite bacteriana

D) Síndrome serotoninérgica

---

52 Homem de 32 anos, engenheiro, teve crise tônico-clônica generalizada única à tarde, no escritório, presenciada por colegas, com 2 minutos de duração e confusão por 20 minutos. Dormiu bem na véspera, não bebe, não usa drogas nem medicações. Nega crises prévias, abalos ao acordar, episódios de desligamento, trauma ou infecção recente; sem história familiar de epilepsia. Exame neurológico normal. Glicemia, sódio, cálcio e magnésio normais. RM de encéfalo com protocolo para epilepsia normal e EEG com privação de sono normal. Não dirige profissionalmente. A conduta mais adequada é:

A) Valproato por 6 meses

B) Não iniciar droga anticrise

C) Levetiracetam por 2 anos

D) Fenitoína até novo EEG

---

53 Mulher de 48 anos, na 3ª semana de RHZE em dose por peso para tuberculose pulmonar, comparece à consulta de rotina. Está assintomática: sem náuseas, vômitos, dor abdominal ou icterícia, e com apetite preservado. Não consome álcool e não usa outras medicações. ALT antes do tratamento: 22 U/L. Exames de hoje: ALT 152 U/L e AST 128 U/L (limite superior da normalidade de 40 U/L para ambas), bilirrubina total 0,9 mg/dL, fosfatase alcalina normal, INR 1,0. Anti-HIV, HBsAg e anti-HCV não reagentes. A conduta mais adequada é:

A) Suspender o esquema até normalizar

B) Suspender só a pirazinamida

C) Manter RHZE e repetir enzimas

D) Trocar por esquema sem rifampicina

---

54 Homem de 24 anos, militar, previamente hígido, apresenta dor muscular difusa e urina escura após marcha de 30 km sob calor intenso no dia anterior. Exame: lúcido, PA 124/76 mmHg, FC 96 bpm, temperatura 37,5 °C, mucosas secas, sem sinais de Chvostek ou Trousseau, sem parestesias. Exames: CPK 68.000 U/L, creatinina 1,6 mg/dL, ureia 48 mg/dL, potássio 5,7 mEq/L, cálcio total 7,2 mg/dL, albumina 4,2 g/dL, fósforo 6,1 mg/dL, bicarbonato 21 mEq/L. Urina: fita com sangue 3+ e 2 hemácias por campo. ECG: ritmo sinusal, sem alterações. A conduta mais adequada é:

A) Cristaloide intravenoso vigoroso

B) Bicarbonato de sódio e manitol

C) Hemodiálise de urgência

D) Gluconato de cálcio e cristaloide

---

55 Mulher de 33 anos, com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto em uso de levotiroxina 100 µg/dia, com TSH de 1,6 µUI/mL há dois meses, descobre-se grávida, com seis semanas, pelo atraso menstrual e beta-hCG positivo. Assintomática. A primeira consulta de pré-natal está marcada para daqui a três semanas. Até lá, em relação à levotiroxina, a conduta mais adequada é:

A) Aumentar cerca de 30% da dose já

B) Dobrar a dose e dosar T4 total

C) Trocar por liotironina na gestação

D) Manter a dose e dosar TSH no pré-natal

---

56 Homem de 63 anos com carcinoma pulmonar de não pequenas células em uso de pembrolizumabe (6º ciclo há 2 semanas), tratado há 3 semanas com amoxicilina-clavulanato por sinusite, tem há 5 dias 9 evacuações aquosas por dia (basal: 1), com cólica e sem sangue. Exame: Tax 37,4 °C, FC 102 bpm, PA 112 × 70 mmHg, abdome doloroso difusamente, sem peritonite. Exames: PCR 96 mg/L, potássio 3,2 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL; pesquisa de toxinas A/B e PCR para C. difficile negativas; coprocultura e painel molecular fecal negativos; calprotectina 820 µg/g. TC: espessamento difuso do cólon, sem perfuração. A conduta mais adequada é:

A) Suspender a imunoterapia e corticoide IV

B) Infliximabe isolado, sem corticoide

C) Loperamida, mantendo a imunoterapia

D) Vancomicina oral, mantendo a imunoterapia

---

57 Mulher de 26 anos, com cardiomiopatia hipertrófica diagnosticada há 4 anos, em uso de bisoprolol 5 mg, teve há 2 meses perda súbita de consciência em repouso, sentada, sem pródromos, com recuperação espontânea em 1 minuto. Sem morte súbita na família. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 58 bpm, sopro sistólico 2/6 em borda esternal esquerda. Ecocardiograma: espessura septal máxima de 27 mm, átrio esquerdo de 46 mm, gradiente na via de saída do VE de 18 mmHg em repouso e de 34 mmHg com Valsalva, FE 68%. Holter: dois episódios de taquicardia ventricular não sustentada, de 6 e 8 batimentos. A conduta mais adequada é:

A) Ablação septal alcoólica

B) Cardiodesfibrilador implantável

C) Aumentar o betabloqueador e repetir o Holter

D) Amiodarona oral

---

58 Homem de 33 anos, previamente hígido, teve trombose venosa profunda poplítea direita no 9º dia após reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com imobilização gessada. Tratado com rivaroxabana, completou 3 meses, com trombo recanalizado ao Doppler e sem sintomas. Não há história familiar de trombose. Exame físico normal; hemograma, função renal e hepática normais. Ele pergunta por exames "para ver se o sangue é grosso" e se deve continuar o remédio. A conduta mais adequada é:

A) Manter anticoagulação indefinidamente

B) Pesquisar trombofilia antes de decidir

C) Suspender sem pesquisar trombofilia

D) Rivaroxabana 10 mg por mais 1 ano

---

59 Mulher de 70 anos usa denosumabe 60 mg a cada 6 meses há 5 anos, sem fraturas, com T-escore atual de -1,9 em colo femoral, e o tratamento será interrompido. Para prevenir a perda óssea acelerada e as fraturas vertebrais múltiplas após a suspensão, recomenda-se:

A) Teriparatida logo após a última dose

B) Reduzir para uma aplicação anual

C) Observar e repetir densitometria em 2 anos

D) Zoledronato cerca de 6 meses após a última dose

---

60 Mulher de 58 anos, que nunca fumou, tem adenocarcinoma de pulmão com metástases ósseas e hepáticas, diagnosticado por biópsia hepática. ECOG 1. Ressonância de crânio: duas metástases assintomáticas de 6 mm. Imuno-histoquímica: PD-L1 expresso em 85% das células tumorais. Painel molecular por sequenciamento de nova geração: deleção do éxon 19 do EGFR; ALK, ROS1 e KRAS sem alterações. O tratamento de primeira linha mais adequado é:

A) Pembrolizumabe isolado

B) Quimioterapia com pembrolizumabe

C) Osimertinibe oral

D) Radiocirurgia e depois quimioterapia

---

61 Homem de 71 anos, com marca-passo bicameral implantado há 14 meses por bloqueio atrioventricular total, diabético, procura o pronto-socorro por febre intermitente, calafrios e astenia há 3 semanas. Não tem cateter venoso, prótese valvar nem procedimento recente. Exame: T 38,3 °C, FC 70 bpm em ritmo de marca-passo, PA 126 × 74 mmHg, loja do gerador sem dor, hiperemia, flutuação ou erosão da pele, sem sopros e sem estigmas periféricos de endocardite. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 9,6 mg/dL, EAS normal, radiografia de tórax sem alterações. Três pares de hemoculturas periféricas, colhidos em horários diferentes antes de antibiótico: Staphylococcus epidermidis resistente à oxacilina em todos os frascos, com o mesmo antibiograma. Ecocardiograma transtorácico: valvas sem vegetações, eletrodos mal avaliados pela janela acústica. O próximo exame mais adequado é:

A) PET-CT com FDG

B) Ecocardiograma transesofágico

C) Nenhum exame adicional

D) Novo transtorácico em 7 dias

---

62 Homem de 47 anos, com prolapso de valva mitral, fez tratamento dentário há dois meses. Há seis semanas tem febre vespertina, perda de 6 kg e artralgias e, há dez dias, petéquias em membros inferiores e urina escura. Exame: temperatura 38,1 °C, PA 138/84 mmHg, sopro sistólico mitral 3+/6+, esplenomegalia discreta. Hemoculturas: Streptococcus mitis em três de três amostras. Ecocardiograma transtorácico: prolapso mitral com insuficiência moderada, sem vegetação definida. Exames: hemoglobina 9,6 g/dL, creatinina 2,8 mg/dL (1,0 há três meses), urina com hemácias dismórficas e cilindros hemáticos, proteinúria de 24 h de 1,4 g, C3 52 mg/dL (90 a 180), C4 14 mg/dL (10 a 40), fator reumatoide reagente e anti-PR3 reagente (28 U/mL, positivo acima de 10). O diagnóstico da lesão renal é:

A) Vasculite associada ao ANCA

B) Glomerulonefrite da endocardite

C) Crioglobulinemia mista

D) Nefrite intersticial por antibiótico

---

63 Homem de 34 anos, sem comorbidades, procura o pronto-socorro por um episódio de fezes enegrecidas pela manhã, após 5 dias de ibuprofeno para lombalgia. Sem hematêmese, síncope ou tontura; sem hepatopatia, cardiopatia ou uso de anticoagulante. Exame: PA 128 × 78 mmHg, FC 82 bpm, sem hipotensão postural, abdome indolor, toque retal com fezes castanhas. Exames: hemoglobina 14,6 g/dL, ureia 32 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, INR 1,0, plaquetas 260.000/mm³. Mora perto do hospital e tem acompanhante. Quanto à endoscopia digestiva alta, o momento mais adequado é:

A) Em até 12 horas, internado

B) Ambulatorial, após a alta

C) Em até 24 horas, internado

D) Dispensável, com IBP empírico

---

64 Homem de 67 anos, com adenocarcinoma de próstata com metástases ósseas em bloqueio androgênico, procura o ambulatório por dor dorsal torácica há 3 semanas, em faixa, que piora ao deitar, à tosse e ao espirro e o acorda de madrugada. Nega fraqueza, alteração urinária ou intestinal. Exame: dor à percussão de T8, força 5/5, reflexos normais, sem nível sensitivo, Babinski ausente. Radiografia de coluna torácica sem colapso vertebral. Cintilografia óssea de 4 meses atrás: captação em bacia e costelas. RM de coluna lombossacra feita há 3 semanas, pedida pelo ortopedista no início da dor: discopatia degenerativa, sem lesões ósseas. O próximo passo mais adequado é:

A) Dexametasona e radioterapia empíricas

B) RM de toda a coluna

C) Analgesia e reavaliação em 2 semanas

D) Nova cintilografia óssea

---

65 Homem de 29 anos, com esquizofrenia estável há dois anos em uso de risperidona 6 mg/dia, queixa-se de disfunção erétil e redução da libido há oito meses. A prolactina antes da risperidona, dosada em internação psiquiátrica, era de 11 ng/mL. Sem cefaleia ou alteração visual. Exame: ginecomastia bilateral discreta, testículos de volume normal, campimetria de confrontação normal. Exames: prolactina 142 ng/mL (até 15) em duas dosagens, testosterona total 210 ng/dL (300 a 1.000), LH 1,8 UI/L, TSH 1,6 µUI/mL, creatinina 0,9 mg/dL. O psiquiatra concorda em ajustar o tratamento. A conduta mais adequada é:

A) Cabergolina mantendo a risperidona

B) Testosterona mantendo a risperidona

C) Trocar a risperidona por aripiprazol

D) Ressonância magnética de sela

---

66 Homem de 52 anos, com diabetes tipo 2 há 5 anos em uso de metformina, sem doença cardiovascular estabelecida, tem PA de consultório de 162×100 mmHg em três consultas, confirmada por MAPA (média de 24 horas de 154×96 mmHg). Relação albumina/creatinina urinária de 80 mg/g, TFG 82 mL/min, potássio 4,3 mEq/L. Já tenta medidas não farmacológicas há 3 meses. O tratamento inicial e a meta pressórica de consultório são, respectivamente:

A) Monoterapia com BRA / abaixo de 130×80

B) Monoterapia com BRA / abaixo de 140×90

C) BRA associado a BCC / abaixo de 140×90

D) BRA associado a BCC / abaixo de 130×80

---

67 Homem de 61 anos, no 3º dia de internação por choque séptico de foco urinário por E. coli, em uso de noradrenalina, evolui com rebaixamento do nível de consciência, sangramento em sítios de cateter e petéquias. Exames: Hb 8,8 g/dL, plaquetas 31.000/mm³ (162.000 na admissão), esquizócitos em 1,5% das hemácias, LDH 780 U/L, creatinina 2,9 mg/dL, INR 2,2, TTPa 52 s (controle 30 s), fibrinogênio 88 mg/dL e D-dímero acima de 20 vezes o limite superior. O diagnóstico e a medida hemostática mais adequada são, respectivamente:

A) PTT / plasmaférese

B) PTT / crioprecipitado

C) CIVD / plasmaférese

D) CIVD / crioprecipitado

---

68 Homem de 67 anos procura atendimento por icterícia indolor progressiva há 4 semanas, com prurido, colúria e perda de 4 kg. Recebeu diagnóstico de diabetes há 3 meses. Nega etilismo. Há 1 ano teve aumento indolor das glândulas lacrimais, que regrediu espontaneamente. Exame físico: ictérico, vesícula não palpável, sem massas abdominais. Exames: bilirrubina total 9,4 mg/dL (direta 8,1), fosfatase alcalina 610 U/L, GGT 840 U/L, lipase normal, CA 19-9 de 168 U/mL (VR < 37), IgG4 sérica de 410 mg/dL (VR < 135). TC de abdome com contraste: aumento da cabeça do pâncreas com área hipoatenuante de 2,8 cm, dilatação do ducto pancreático principal a montante de 6 mm com atrofia do corpo e da cauda, e dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas. O próximo passo mais adequado é:

A) Ecoendoscopia com biópsia por agulha

B) PET-CT de corpo inteiro

C) Repetir IgG4 sérica em 4 semanas

D) Prova terapêutica com prednisona

---

69 Mulher de 81 anos, hipertensa, com incontinência de urgência e insônia, teve três quedas nos últimos 2 meses, todas ao levantar da cama à noite para urinar, uma com fratura de punho. Usa losartana 50 mg/dia há 5 anos, oxibutinina 5 mg duas vezes ao dia há 3 meses, amitriptilina 25 mg à noite há 2 meses, para insônia, e betaistina, iniciada após a segunda queda por labirintite. Refere tontura de quem vai desmaiar, sem vertigem rotatória. Exame: PA deitada 142 × 80 mmHg e, após 3 minutos em pé, 112 × 66 mmHg, com FC de 76 para 98 bpm; Dix-Hallpike negativo; marcha lenta, sem sinais extrapiramidais. MEEM 24 (era 28 há 1 ano). A conduta mais adequada para reduzir novas quedas é:

A) Suspender amitriptilina e oxibutinina

B) Iniciar donepezila 5 mg/dia

C) Iniciar fludrocortisona 0,1 mg/dia

D) Reabilitação vestibular e manter betaistina

---

70 Homem de 31 anos, trabalhador rural do interior de Minas Gerais, procura atendimento no 6º dia de doença. Há 10 dias limpou a casa após uma enchente, com água até os joelhos. Há 15 dias passou um fim de semana acampado em área de mata onde foram encontrados macacos mortos. Não tem registro de vacinação. O quadro começou com febre alta súbita, cefaleia, mialgia intensa e dor lombar; melhorou no 3º dia por cerca de 24 horas e, a seguir, voltou a febre, com vômitos, icterícia e sangramento gengival. Exame: T 38,9 °C, FC 64 bpm, PA 108 × 70 mmHg, ictérico 3+/4+, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores. AST 4.800 U/L, ALT 3.100 U/L, bilirrubina total 9,2 mg/dL (direta 7,4), creatinina 2,9 mg/dL, potássio 4,6 mEq/L, CK 210 U/L, plaquetas 52.000/mm³, leucócitos 3.100/mm³, INR 2,4. O diagnóstico mais provável é:

A) Dengue com acometimento hepático

B) Hepatite A fulminante

C) Febre amarela grave

D) Leptospirose, forma ictero-hemorrágica

---

71 Homem de 67 anos, em uso de sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina e furosemida 40 mg/dia, chega com dor epigástrica em faixa há 8 horas e vômitos. Lipase 1.900 U/L; ultrassonografia com colelitíase, sem dilatação de vias biliares. Exame: Tax 37,2 °C, FC 98 bpm, PA 112 × 70 mmHg, FR 20 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, mucosas secas, jugulares não túrgidas a 45 graus, sem estertores, sem edema; enchimento capilar de 3 s. Exames: hematócrito 46%, ureia 58 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL (basal 1,1), lactato 2,0 mmol/L, glicemia 128 mg/dL, bicarbonato 23 mEq/L. A reposição volêmica inicial mais adequada é:

A) Ringer lactato 10 mL/kg e 1,5 mL/kg/h

B) Ringer lactato 20 mL/kg e 3 mL/kg/h

C) Soro fisiológico 250 mL/h fixos por 48 horas

D) Restrição hídrica pela insuficiência cardíaca

---

72 Homem de 23 anos, estudante, tem há 3 semanas formigamento ascendente nos pés e nas mãos e, há 1 semana, desequilíbrio que piora no escuro. Nega viagens e sexo desprotegido; conta que, nos últimos 4 meses, usa com os amigos 'balões' de festa quase todo fim de semana. Exame: vibratória e propriocepção abolidas até os joelhos, Romberg presente, reflexos patelares vivos, aquileus abolidos, Babinski bilateral. Hemoglobina 14,1 g/dL, VCM 91 fL, vitamina B12 sérica 410 pg/mL (VR 200 a 900), cobre sérico e VDRL normais, HIV não reagente. RM de medula: hipersinal em T2 nos cordões posteriores de C2 a C6, em 'V invertido'. A etiologia mais provável é:

A) Esclerose múltipla, forma medular

B) Mielopatia por deficiência de cobre

C) Inativação da B12 pelo óxido nitroso

D) Mielite transversa pós-viral

---

73 Mulher de 34 anos, com doença renal policística autossômica dominante, vem a consulta de seguimento. A mãe iniciou hemodiálise aos 52 anos pela mesma doença, e um tio materno, também portador da doença, morreu aos 45 anos de hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma. Está assintomática, com PA de 126/80 mmHg em uso de losartana. Exames: creatinina 1,0 mg/dL, TFGe 76 mL/min/1,73 m², potássio 4,4 mEq/L. Ressonância de abdome: volume renal total ajustado à altura compatível com a classe 1D de Mayo. Quanto ao rastreamento de aneurisma intracraniano e à tolvaptana, as condutas são, respectivamente:

A) Rastrear aneurisma / iniciar tolvaptana

B) Rastrear aneurisma / não iniciar tolvaptana

C) Não rastrear / iniciar tolvaptana

D) Não rastrear / não iniciar tolvaptana

---

74 Homem de 47 anos, com obesidade (IMC 35 kg/m²), diabetes tipo 2 há 4 anos, hipertrigliceridemia e esteatose hepática, bebe duas latas de cerveja nos fins de semana. Há um ano, uma ferritina de 860 ng/mL foi atribuída à síndrome metabólica e ele foi orientado a perder peso, o que não conseguiu. Nega transfusões, artralgia, hiperpigmentação ou disfunção erétil. Exames atuais: hemoglobina 15,6 g/dL, ferritina 910 ng/mL, ferro sérico 212 µg/dL, saturação de transferrina 74% (repetida em jejum: 71%), AST 38 U/L, ALT 56 U/L, plaquetas 236.000/mm³, PCR 3 mg/L. Pesquisa do gene HFE: homozigose C282Y. Elastografia hepática transitória: 5,8 kPa. A conduta mais adequada é:

A) Biópsia hepática antes de tratar

B) Flebotomias semanais

C) Perda de peso, sem flebotomia

D) Deferasirox por via oral

---

75 Mulher de 39 anos, natural de Minas Gerais, teve PTI diagnosticada há 1 mês, com plaquetas de 24.000/mm³ e petéquias em pernas, e está em prednisona 1 mg/kg/dia há 2 semanas, com plaquetas atuais de 58.000/mm³. Tem hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, em levotiroxina. Sem artralgias, fotossensibilidade, úlceras orais ou serosite. Exames: Hb 13,2 g/dL, leucócitos 7.100/mm³, urina tipo 1 normal, creatinina normal, FAN 1:80 com padrão nuclear pontilhado fino, sorologias para HIV e hepatites B e C negativas, imunoglobulinas normais. A investigação adicional com maior potencial de mudar o tratamento é:

A) Mielograma com biópsia

B) Anti-DNA nativo e complemento

C) Pesquisa de H. pylori

D) Anticorpos antiplaquetários

---

76 Mulher de 23 anos, estudante, desmaiou em pé numa fila de banco em dia quente, após 40 minutos sem se alimentar; antes sentiu calor, náusea, visão escurecida e sudorese. Ficou inconsciente por cerca de 20 segundos, com dois abalos dos braços, sem liberação esfincteriana nem confusão depois. Teve episódio semelhante aos 16 anos, em coleta de sangue. O pai teve infarto aos 68 anos. Sem palpitações, sem síncope ao esforço ou deitada, sem morte súbita na família. PA 110×70 mmHg sem queda postural, FC 72 bpm, exames neurológico e cardiovascular normais. ECG: ritmo sinusal, PR 160 ms, QRS 88 ms, QTc 410 ms, sem pré-excitação. Hemoglobina normal, beta-hCG negativo. A conduta mais adequada é:

A) Teste de inclinação

B) Eletroencefalograma e ressonância de crânio

C) Alta com orientação, sem novos exames

D) Ecocardiograma e Holter ambulatoriais

---

77 Homem de 68 anos, diabético, no 9º dia de pós-operatório de clipagem de aneurisma da artéria comunicante anterior, com derivação ventricular externa ainda instalada, evolui com febre de 38,9 °C, piora do nível de consciência (Glasgow de 14 para 11) e rigidez de nuca. Líquor colhido pelo cateter: 1.850 células/mm³ (90% neutrófilos), proteína 220 mg/dL, glicose 18 mg/dL (glicemia 160 mg/dL), Gram sem bactérias visíveis. Os agentes que o esquema empírico deve cobrir prioritariamente são:

A) Estafilococos e Gram-negativos hospitalares

B) Pneumococo, meningococo e Listeria

C) Anaeróbios e estreptococos orais

D) Criptococo e Candida

---

78 Mulher de 71 anos refere dor e rigidez em ombros, pescoço e quadris há 7 semanas, com rigidez matinal de 2 horas e dificuldade para vestir-se. Nega cefaleia, claudicação mandibular, alterações visuais, febre e perda de peso. Tem diabetes tipo 2 com HbA1c 7,1% e osteopenia. Exame físico: dor à mobilização ativa e passiva dos ombros, sem sinovite periférica, força preservada, artérias temporais normais. Exames: VHS 58 mm/h, PCR 3,8 mg/dL, CK, TSH, cálcio e eletroforese de proteínas normais, fator reumatoide e anti-CCP não reagentes. Ultrassonografia: bursite subdeltóidea bilateral. A conduta inicial mais adequada é:

A) Prednisona 1 mg/kg/dia

B) Prednisona 40 mg/dia

C) Prednisona 15 mg/dia

D) Prednisona 5 mg/dia

---

79 Homem de 72 anos, com DPOC grave (VEF1 32% do previsto), chega com piora da dispneia e do escarro há 3 dias. Está sonolento, mas desperta ao chamado e obedece a comandos (Glasgow 14), com tosse eficaz e sem vômitos. PA 146 × 88 mmHg, FC 108 bpm, FR 30 irpm, uso de musculatura acessória e respiração paradoxal. Em cateter de O2 a 2 L/min, SpO2 89%. Gasometria: pH 7,27, PaCO2 72 mmHg, PaO2 58 mmHg, HCO3 33 mEq/L. Iniciados broncodilatadores, prednisona e antibiótico. A medida ventilatória mais adequada neste momento é:

A) Intubação orotraqueal e ventilação mecânica

B) Ventilação não invasiva com dois níveis de pressão

C) Cateter nasal de alto fluxo

D) Aumentar o O2 para SpO2 acima de 94%

---

80 Mulher de 72 anos com câncer de mama metastático para ossos, em cuidados paliativos domiciliares, usava morfina oral 60 mg/dia com bom controle da dor. Há 10 dias a dose foi aumentada para 120 mg/dia por dor no quadril; há 5 dias passou a ingerir pouco líquido e a vomitar. Há 2 dias tem abalos musculares, sonolência alternada com agitação, alucinações visuais e dor generalizada ao toque leve, que piora a cada dose de resgate. Exame: Tax 36,5 °C, mioclonias multifocais, pupilas mióticas, FR 14 irpm, sem déficit focal. Exames: creatinina 2,6 mg/dL (era 0,8 há 1 mês), cálcio corrigido 9,8 mg/dL, sódio 138 mEq/L, glicemia 104 mg/dL. A causa mais provável do quadro é:

A) Hipercalcemia da malignidade

B) Progressão da dor óssea metastática

C) Neurotoxicidade induzida por opioide

D) Metástases cerebrais

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 5

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)	51 (A) (B) (C) (D)	52 (A) (B) (C) (D)
53 (A) (B) (C) (D)	54 (A) (B) (C) (D)	55 (A) (B) (C) (D)	56 (A) (B) (C) (D)
57 (A) (B) (C) (D)	58 (A) (B) (C) (D)	59 (A) (B) (C) (D)	60 (A) (B) (C) (D)
61 (A) (B) (C) (D)	62 (A) (B) (C) (D)	63 (A) (B) (C) (D)	64 (A) (B) (C) (D)
65 (A) (B) (C) (D)	66 (A) (B) (C) (D)	67 (A) (B) (C) (D)	68 (A) (B) (C) (D)
69 (A) (B) (C) (D)	70 (A) (B) (C) (D)	71 (A) (B) (C) (D)	72 (A) (B) (C) (D)
73 (A) (B) (C) (D)	74 (A) (B) (C) (D)	75 (A) (B) (C) (D)	76 (A) (B) (C) (D)
77 (A) (B) (C) (D)	78 (A) (B) (C) (D)	79 (A) (B) (C) (D)	80 (A) (B) (C) (D)